Hạ đường huyết

Dưới 70 mg/dL (3,9 mmol/L)
Có thể run tay, vã mồ hôi, đói, hồi hộp, chóng mặt hoặc lú lẫn.

Còn tỉnh, nuốt an toàn

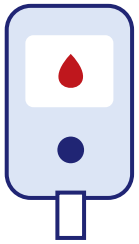
1. Dùng 15 g đường hấp thu nhanh: viên glucose đủ 15 g theo nhãn, hoặc khoảng 120 mL nước ép / nước ngọt có đường.

2. Chờ 15 phút, đo lại. Nếu vẫn dưới 70 mg/dL, lặp lại. Khi hồi phục, ăn bữa chính hoặc bữa phụ có chất bột đường và đạm.

Bất tỉnh, co giật, khó nuốt

Không cho ăn, uống hoặc đổ đường vào miệng. Gọi cấp cứu ngay. Dùng glucagon nếu đã được kê và người hỗ trợ đã được hướng dẫn.

Quy tắc trên dành cho người lớn. Trẻ em cần hướng dẫn riêng.



Mang theo máy đo
và đường hấp thu nhanh
nếu có nguy cơ hạ đường huyết.

Khi nào cần trợ giúp?

Đến cấp cứu ngay khi

• Lơ mơ, bất tỉnh, co giật hoặc hạ đường huyết không cải thiện.

• Nôn nhiều, đau bụng, thở nhanh hoặc khó thở, đặc biệt khi đường huyết cao.

Khám sớm, không chờ lịch hẹn

Bàn chân có vết thương, sưng đỏ, phồng rộp hoặc chảy dịch; hạ đường huyết tái diễn; đường huyết thường ngoài mục tiêu.

Chuẩn bị khi tái khám

Mang sổ đường huyết, đơn thuốc và danh sách điều đang băn khoăn. Hỏi bác sĩ về mục tiêu đường huyết và kế hoạch khi bị ốm.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Nguồn tham khảo: WHO - Diabetes; CDC - Meal Planning, Low Blood Sugar, Your Feet, Ketoacidosis.
Biên soạn: 15/10/2026. Bản dự thảo để bệnh viện duyệt trước khi phát hành.

WHO: Đái tháo đường

CDC: Hạ đường huyết

Bệnh viện đa khoa NHẬT TÂN

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Chăm sóc mỗi ngày để phòng biến chứng

Dành cho người trưởng thành mắc đái tháo đường và người chăm sóc.

ĂN HỢP LÝ
DÙNG THUỐC ĐÚNG
THEO DÕI ĐỀU

Đái tháo đường là bệnh mạn tính. Điều trị và chăm sóc đều đặn giúp giảm nguy cơ tổn thương tim, mắt, thận và bàn chân.

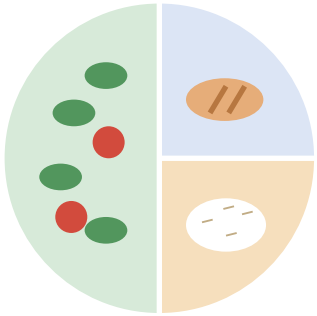
Kế hoạch điều trị cần phù hợp với từng người theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nguồn: WHO; CDC | Tra cứu: 15/10/2026

Ăn uống hợp lý

Ăn đúng bữa, lượng vừa đủ. Trao đổi với nhân viên y tế để chọn khẩu phần phù hợp.

Gợi ý một đĩa ăn cân đối



• **½ đĩa:** rau ít tinh bột như rau lá, cải, dưa leo.

• **¼ đĩa:** cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ.

• **¼ đĩa:** cơm, bún, khoai hoặc thực phẩm có chất bột đường.

Chọn nước lọc; hạn chế nước ngọt, trà sữa. Ăn trái cây nguyên miếng với lượng phù hợp, hạn chế nước ép.

Không tự bỏ hoàn toàn cơm và chất bột đường. Người có bệnh thận hoặc mang thai cần tư vấn riêng.

Điều trị mỗi ngày

Dùng thuốc đúng đơn

Uống thuốc, tiêm insulin đúng hướng dẫn. Không tự tăng, giảm hoặc ngừng thuốc khi thấy đường huyết ổn. Hỏi cách xử trí nếu quên liều.

Theo dõi và ghi chép

Đo đường huyết theo lịch được hướng dẫn; ghi kết quả, bữa ăn, vận động và triệu chứng bất thường. Mục tiêu đường huyết khác nhau ở từng người.

Vận động phù hợp

Duy trì vận động đều, bắt đầu nhẹ và tăng dần theo sức khỏe. Hỏi nhân viên y tế loại hoạt động an toàn, nhất là khi có bệnh tim hoặc vết loét chân.

Phòng biến chứng

Không hút thuốc. Tái khám đúng hẹn; kiểm tra mắt, thận, bàn chân, huyết áp và mỡ máu theo chỉ định.

Luôn mang theo: thông tin bệnh, danh sách thuốc và đường hấp thu nhanh nếu có nguy cơ hạ đường huyết.

Bảo vệ bàn chân

Tổn thương thần kinh có thể làm chân mất cảm giác. Vết thương nhỏ vẫn cần được chú ý.

• **Nhìn kỹ mỗi ngày:** lòng bàn chân, kẽ ngón; dùng gương hoặc nhờ người thân.

• Rửa bằng nước ấm, không nóng; không ngâm chân. Lau khô, nhất là kẽ ngón.

• Dưỡng ẩm da khô nhưng không bôi vào kẽ ngón.

• Mang giày dép vừa chân; kiểm tra bên trong trước khi mang. Không đi chân trần, kể cả trong nhà.

• Cắt móng ngang; không tự cắt chai chân hoặc dùng thuốc tẩy chai.

Có vết loét, phồng rộp, sưng đỏ hoặc chảy dịch: đi khám sớm, kể cả khi không đau.

Nhờ nhân viên y tế kiểm tra bàn chân trong các lần khám và khám toàn diện theo lịch được hướng dẫn.



Giày vừa chân
Kiểm tra trước khi mang

Nguồn: WHO; CDC | Tra cứu: 15/10/2026